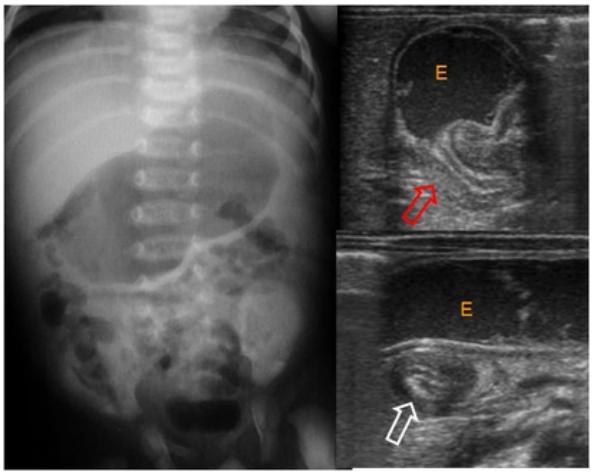
CIRUGÍA PEDIÁTRICA II

DR. RAMÓN A. POLICART

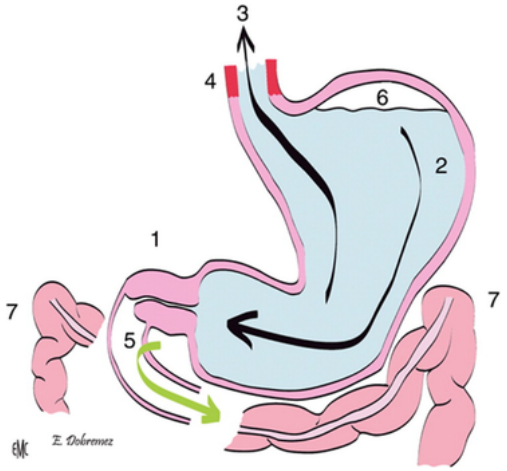
HIPERTROFIA DEL PÍLORO: DIAGNÓSTICO

- Historia clínica orienta en el 90% de los casos.
- Rx simple.
- Gold standard: USG abdominal, donde se visualiza el píloro engrosado.



HIPERTROFIA DEL PÍLORO: CLÍNICA

- Vómitos no biliosos, en proyectil, progresivos, típicamente entre la 3a y 6a semana de vida.
- Lactante hambriento después de vomitar; puede palparse la "oliva pilórica" en epigastrio/hipocondrio derecho.
- Alcalosis metabólica hipoclóremica e hipokalémica por la pérdida de ácido clorhídrico en el vómito.

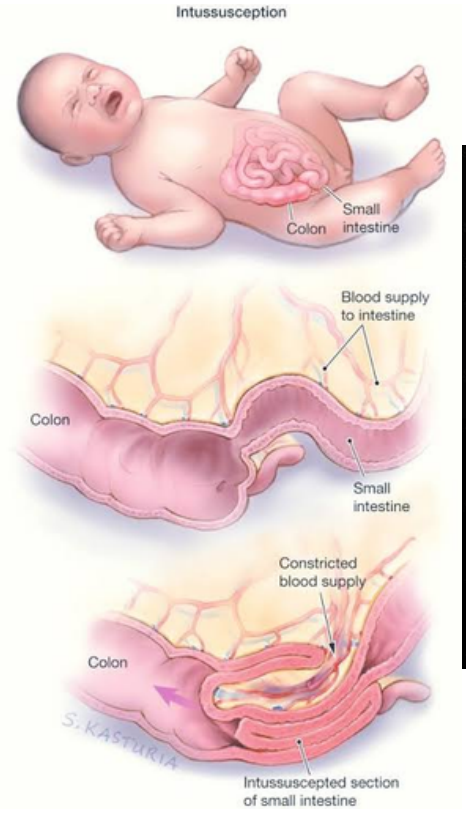


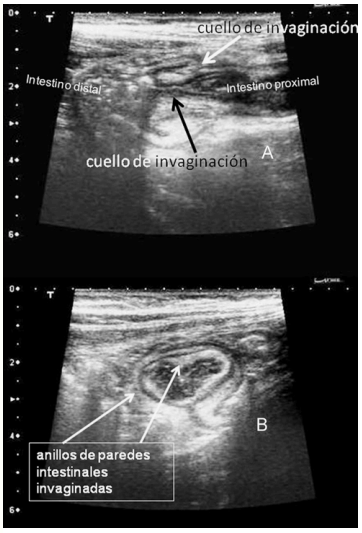
INVAGINACIÓN INTESTINAL: ETIOLOGÍA

- Se presenta entre los 6 meses y 1 año de edad.
- Más común en primavera y otoño, lo que sugiere asociación viral.
- Factores propuestos: hiperplasia del tejido linfoide, infecciones virales (ej. rotavirus), posterior a un cuadro infeccioso.

INVAGINACIÓN INTESTINAL: CLÍNICA

- Síntomas: irritabilidad, dolor abdominal intermitente, vómitos, letargia.
- Heces en "jalea de grosella" (con sangre): presente en 60% de los casos, es patognomónico.
- Examen físico: dolor a la palpación, masa abdominal en forma de "salchicha/chorizo" en fosa ilíaca derecha.





CIRUGÍA PEDIÁTRICA II

DR. RAMÓN A. POLICART

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESTENOSIS PILÓRICA

- 1–3 por cada 1 000 nacidos vivos; 4–5 veces más en varones, típicamente primogénitos; más riesgo con antecedente familiar y uso de macrólidos (eritromicina) en las primeras semanas.

FISIOPATOLOGÍA

- Hipertrofia e hiperplasia progresiva de la capa muscular circular del píloro que obstruye el vaciamiento gástrico; no está presente al nacer, se desarrolla en las primeras semanas.

CRITERIOS ECOGRÁFICOS

- Grosor del músculo pilórico ≥3–4 mm y longitud del canal ≥15–17 mm, sin paso del contenido gástrico.

SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL

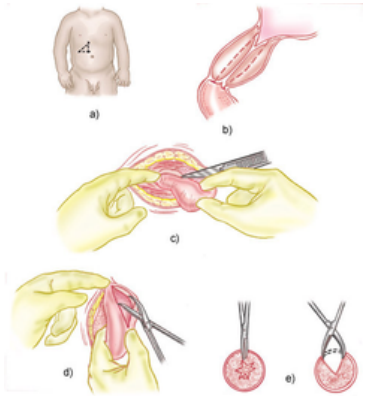
- Útil si el USG no es concluyente: signos de la cuerda, del doble riel y del hombro.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

- La cirugía no es urgente: primero corregir deshidratación y alcalosis (cloro >100 mEq/L, bicarbonato <30, potasio normal) con soluciones con NaCl y KCl una vez que orine.
- Operar con alcalosis aumenta el riesgo de apnea posanestésica.

PILOROMIOTOMÍA DE RAMSTEDT

- Sección longitudinal del músculo pilórico hasta que la mucosa protruya, sin abrirla; abierta o laparoscópica.
- Complicaciones: perforación mucosa (se repara), miotomía incompleta y vómitos transitorios.



POSOPERATORIO

- Reinicio de la alimentación en pocas horas; los vómitos leves iniciales son frecuentes y autolimitados.

TIPOS DE INVAGINACIÓN

- Ileocólica, la más frecuente (~85–90%); también ileoileal y colocólica.
- El segmento proximal se introduce en el distal y compromete primero el retorno venoso y luego el arterial.

PUNTO GUÍA PATOLÓGICO

- Más probable fuera de la edad típica (>2–3 años) o en recurrencias: divertículo de Meckel, pólipos, duplicaciones, linfoma, púrpura de Henoch-Schönlein y fibrosis quística.

TRÍADA CLÁSICA

- Dolor cólico intermitente (encoge las piernas), vómitos y heces en jalea de grosella: completa en menos de un tercio; la letargia puede ser el único signo.

SIGNO DE DANCE

- Vacío a la palpación en la fosa ilíaca derecha por desplazamiento del ciego.

ULTRASONIDO EN INVAGINACIÓN

- Estudio de elección (sensibilidad y especificidad cercanas al 100%): «diana» o «donut» en corte transversal y «pseudorriñón» en longitudinal.

REDUCCIÓN NO QUIRÚRGICA

- Enema hidrostático o neumático guiado por USG o fluoroscopia en el paciente estable: éxito 80–90%.
- Contraindicada ante peritonitis, perforación (neumoperitoneo) o choque.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INVAGINACIÓN

- Si falla la reducción o está contraindicada: reducción manual por expresión (no tracción); resección si hay necrosis o punto guía.
- Recurrencia ~10% tras el enema, menor tras la cirugía.

MALROTACIÓN INTESTINAL

- Falla de la rotación de 270° del intestino medio alrededor de la arteria mesentérica superior: bandas de Ladd que cruzan el duodeno y mesenterio de base estrecha.

VÓLVULO DEL INTESTINO MEDIO

- Vómito bilioso en un neonato = emergencia quirúrgica hasta demostrar lo contrario, por riesgo de necrosis de todo el intestino medio.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA II

DR. RAMÓN A. POLICART



DIAGNÓSTICO DE MALROTACIÓN

- Serie EGD: ángulo de Treitz a la derecha de la línea media; imagen en «sacacorchos» en el vólvulo.
- USG: inversión de la relación AMS/VMS y signo del remolino.

PROCEDIMIENTO DE LADD

- Destorsión antihoraria, sección de las bandas de Ladd, ampliación de la base mesentérica, apendicectomía e intestino delgado a la derecha y colon a la izquierda.

ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG

- Ausencia de células ganglionares (plexos de Meissner y Auerbach) por falla de migración de la cresta neural; inicia en el recto y avanza en sentido proximal (rectosigmoidea en ~75–80%).

CLÍNICA DE HIRSCHSPRUNG

- Sin evacuación de meconio en las primeras 48 h, distensión y vómitos biliosos; en niños mayores, estreñimiento crónico grave.
- Tacto rectal con salida explosiva de heces y gas.

DIAGNÓSTICO DE HIRSCHSPRUNG

- Enema con contraste: zona de transición; manometría: ausencia del reflejo inhibitorio anal.
- Gold standard: biopsia rectal por succión (sin células ganglionares, aumento de acetilcolinesterasa).

TRATAMIENTO DE HIRSCHSPRUNG

- Descenso endorrectal (Soave), Swenson o Duhamel; colostomía previa si hay enterocolitis.
- Enterocolitis: la complicación más temida (fiebre, distensión, diarrea explosiva).

MALFORMACIONES ANORRECTALES

- 1 por cada 4 000–5 000 nacidos vivos; frecuentemente asociadas a VACTERL.
- Se clasifican según la presencia y localización de la fístula (perineal, vestibular, uretral, vesical).

MANEJO DE LAS MALFORMACIONES ANORRECTALES

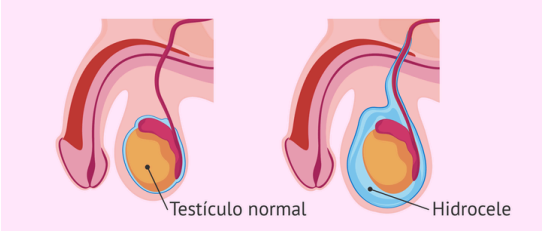
- Esperar 24 h a que aparezca meconio en el periné o una fístula.
- Fístula perineal: anoplastia primaria; sin fístula visible o fístula alta: colostomía y luego anorrectoplastia sagital posterior (Peña).

HERNIA INGUINAL PEDIÁTRICA

- Persistencia del conducto peritoneovaginal (indirecta); más en varones y prematuros.
- Reparación electiva temprana (ligadura alta del saco, sin malla) por alto riesgo de incarceración en el primer año.

HIDROCELE

- No comunicante: suele resolverse antes de los 12–24 meses. Comunicante (cambia de tamaño durante el día): se trata como una hernia.



CRIPTORQUIDIA

- Testículo no descendido; el descenso espontáneo es poco probable después de los 6 meses.
- Orquidopexia entre los 6 y 18 meses para preservar la fertilidad y facilitar la vigilancia del riesgo de cáncer testicular.

FIMOSIS Y PARAFIMOSIS

- Fimosis fisiológica hasta los 3–4 años; tratamiento con corticoide tópico; circuncisión si es cicatricial o hay balanitis o infecciones urinarias recurrentes.
- Parafimosis: urgencia; reducción manual.

HERNIA UMBILICAL INFANTIL

- La mayoría cierra espontáneamente antes de los 4–5 años; cirugía si persiste después de esa edad o si el defecto es >1,5–2 cm.